NUMER 31
05.10.2026

PSYCHOWIEŚCI

NEWSLETTER SKN PSYCHOTERAPII
"DIALOG"

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PSYCHOTERAPII DIALOG

Prezentujemy Państwu kolejny numer „PsychoWieści", a w nim: dwa teksty podsumowujące nowo opublikowane artykuły naukowe z dziedziny psychologii i psychoterapii, które wybrał nasz zespół.
Życzymy przyjemnej lektury i dziękujemy za subskrybowanie „PsychoWieści"!

NOWE BADANIA W PIGUŁCE

Epizod depresyjny a chroniczny ból – jaki mają na siebie wpływ, w zależności od kolejności występowania?

Dotychczasowe badania dotyczące epizodów depresyjnych i chronicznym bólem pokazały, że posiadanie jednego z nich zwiększa ryzyko wystąpienia drugiego. Co więcej, ich współwystępowanie prowadzi do gorszego funkcjonowania w codziennym życiu, a także powiązane jest z gorszymi prognozami klinicznymi czy wyższym stopniem niepełnosprawności. Lepsze zrozumienie powiązania depresji i chronicznego bólu wydaje się więc kluczowe dla poprawy sytuacji osób zmagających się z tymi stanami.

W opisywanym badaniu wzięło udział 35 osób (54,3% kobiet), a mediana wieku wyniosła 35,6 lat (SD: 7,2). Chroniczny ból zdefiniowany został jako ból, który utrzymuje się ponad trzy miesiące. Na podstawie odpowiedzi na kwestionariusze bólu McGill i Lubeck subiektywne nasilenie bólu zostało sklasyfikowane na skali od 0 do 78. Określono także liczbę obszarów ciała, w których osoby badane zgłaszały występowanie chronicznego bólu.Informacje o wystąpieniu epizodu depresyjnego zebrano w toku usystematyzowanego wywiadu. Co warto zaznaczyć, z badania wykluczono osoby m.in. zmagające się z bólem w przebiegu nowotworu czy stwardnienia rozsianego, a także mające historię zaburzeń neurologicznych. Wykluczono także osoby w aktywnym uzależnieniu oraz te mające nasilenie chorób psychicznych wiążących się z psychozą lub aktywnymi myślami samobójczymi.



Osoby badane podzielono na trzy grupy: tych, u których pierwszy epizod depresyjny wystąpił przed pojawieniem się chronicznego bólu (1), tych, u których chroniczny ból poprzedzał pierwszy epizod depresyjny (2), a także na tych, u których nie stwierdzono wystąpienia epizodu depresyjnego w ogóle (3). Analiza regresji liniowej pokazała, że osoby z grupy 1 opisywały wyższe nasilenie bólu, a także większą liczbę miejsc w ciele w których odczuwali ból, niż osoby z grupy 3. Chociaż różnice między grupą 1 a 2 nie były istotne statystycznie, to, jak sami autorzy podkreślają, wyniki grupy 2 plasowały się między wynikami grupy 1 a 3 w większości kategorii.

Wyniki pozwalają lepiej zrozumieć zależność między chronicznym bólem a epizodami depresyjnymi. Z uwagi na niewielką liczebność próby, ciężko wyciągać daleko idące wnioski, jednakże wiele wskazuje na to, że wystąpienie epizodu depresyjnego pogarsza odczuwanie chronicznego bólu w późniejszym życiu (jeżeli takowy się pojawi). Pokazuje to, jak nierozerwalna jest nasza psychika od naszych odczuć fizjologicznych, a także, że dbanie o zdrowie psychiczne wpływa na całokształt naszego funkcjonowania.

Gontrum, E., Shah, K., Han, E., Legarreta, M., McGlade, E., Yancey, J., Renshaw, P., & Yurgelun-Todd, D. (2026). **Timing of depressive episode onset relative to chronic pain reveals distinct patterns of affective and multisite pain.** *Frontiers in Psychiatry*, 17, 1813589. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2026.1813589

Osoba autorska: Inga Błażejak
Korekta: Zuzanna Konieczna

Czy muzyka nas leczy?

Zapewne wielu z nas zdarzyło się dostrzec, jak dużą rolę odgrywa w życiu muzyka. Towarzyszy nam przy relaksie, spędzaniu czasu z bliskimi, niekiedy przy wysiłku umysłowym czy fizycznym. Badania z użyciem muzyki jako środka interwencji wskazują na jej pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne, m.in. redukcję objawów depresji, lęku i samotności oraz poprawę samopoczucia. Jednak jak wygląda to w życiu codziennym? Czy nasze naturalne nawyki związane z słuchaniem muzyki wiążą się ze stanem zdrowia psychicznego? Autorzy artykułu postanowili sprawdzić tę zależność, skupiając się na częstotliwości słuchania muzyki oraz jej użyciu do regulacji nastroju. Chcieli również dowiedzieć się, czy ewentualne powiązanie może mieć charakter przyczynowo-skutkowy, czy może jednak wynika z czynników genetycznych i rodzinnych wspólnych dla zdrowia psychicznego i nawyków słuchania muzyki. W tym celu przebadali dwukrotnie grupy bliźniąt – w 2012 roku oraz w 2022 roku. W badaniu użyto kwestionariuszy do określenia częstotliwości słuchania muzyki, ocenienia funkcji muzyki w regulacji nastroju (BMRQ) oraz do pomiaru objawów depresyjnych (Hopkins Symptom Checklist), neurotyzmu (BFI, BFI-2), poczucia samotności (UCLA 3-Item Loneliness Scale) oraz subiektywnego dobrego samopoczucia (WHO well-being questionnaire).

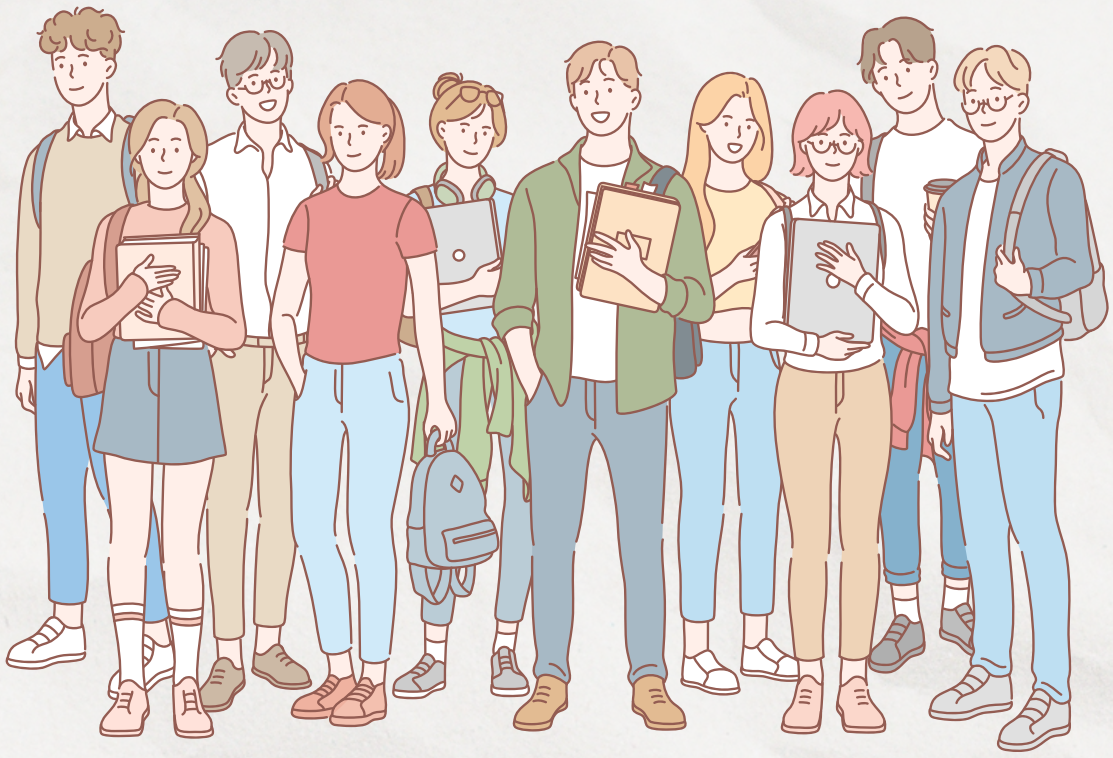


Wesseldijk, L. W., Ullén, F., & Mosing, M. A. (2026). **Does listening to music relate to mental health in the general population: a genetically informed approach**. *Journal of Affective Disorders Reports, 101066*. https://doi.org/10.1556/2006.2026.00022

Osoba autorska: Aleksandra Lubkowska
Korekta: Zuzanna Konieczna



Okazało się, że częstotliwość słuchania muzyki nie wykazuje istotnych powiązań ze stanem zdrowia psychicznego na poziomie populacji. Jednakże, osoby z diagnozą depresji, zaburzeniami lękowymi lub cechujące się wysokim poziomem neurotyzmu czy samotności o wiele częściej używały muzyki w celu poprawy nastroju. Autorzy wnioskowali, że zauważone związki wynikają ze współdzielonych czynników genetycznych i środowiska rodzinnego, a nie z samego wpływu słuchania muzyki na samopoczucie. Ponadto badacze nie znaleźli przesłanek ochronnej funkcji słuchania muzyki na wpływ genetycznych predyspozycji na zdrowie psychiczne. Jednak mimo iż muzyka zdaje się nie być wskaźnikiem zdrowia psychicznego, niezaprzeczalnie jest istotnym elementem naszego życia i pewnym środkiem ekspresji świata wewnętrznego, wartym dalszej eksploracji w badaniach.



Życzymy Państwu powodzenia w tym roku akademickim!

dialogskn.pl

Każdy kolejny numer „PsychoWieści” będzie ukazywał się w pierwszy poniedziałek miesiąca!

Zespół redaktorów i redaktorek „PsychoWieści”: Inga Błażejak, Zuzanna Konieczna, Zuzanna (Zet) Kozłowskie, Martyna Krzempek, Maria Krawczyk, Julia Krajewska, Nina Kędziora, Aleksandra Lubkowska, Małgorzata Michalska, Michał Muszyński, Hubert Patryn, Mateusz Pleskowicz, Patrycja Rakowska, Valeriia Shliakhova, Aleksandra Suska, Agata Wróblewska.

Korekta, koordynacja Newslettera: Zuzanna Konieczna

Osoba Koordynatorska Recenzji: Zet (Zuzanna) Kozłowskie

SKN Psychoterapii „Dialog"
Uniwersytet Warszawski

Stefana Banacha 2D, 02-097 Warszawa

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PSYCHOTERAPII DIALOG